

HoLEP (Holmium Laser Enucleation)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Phẫu thuật laser điều trị tuyến tiền liệt phì đại mọi kích thước

HoLEP là phẫu thuật laser điều trị tuyến tiền liệt phì đại (tăng sản lành tính tuyến tiền liệt — BPH), bóc tách toàn bộ phần mô gây tắc nghẽn qua ống nội soi — **không cần rạch da**. Ưu điểm lớn nhất là phù hợp với **mọi kích thước** tuyến tiền liệt, kể cả tuyến rất lớn trước đây phải mổ mở, ít chảy máu và kết quả lâu dài.

Về ca phẫu thuật này

Qua ống nội soi đưa vào niệu đạo, **laser holmium** bóc tách toàn bộ phần trong tuyến tiền liệt (phần gây tắc nghẽn) ra khỏi lớp vỏ ngoài — tương tự như tách phần thịt ra khỏi vỏ quả. Mô bóc ra được đẩy vào bàng quang, sau đó được nghiền nhỏ và lấy ra ngoài (**morcellation**). Vì loại bỏ toàn bộ phần gây tắc, kết quả **rất bền vững** và hiếm khi cần điều trị lại.

Tại sao chọn HoLEP

- Phù hợp với tuyến tiền liệt **mọi kích thước**, kể cả tuyến rất lớn
- **ít chảy máu** — thường phù hợp với bệnh nhân đang dùng thuốc làm loãng máu
- Thời gian đặt ống thông ngắn và kết quả lâu dài

Đây là kỹ thuật chuyên sâu — kết quả tốt nhất khi được thực hiện bởi bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

HoLEP

Bóc tách tuyến tiền liệt bằng laser Holmium.

BPH

Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (không phải ung thư).

Bóc tách (Enucleation)

Lấy toàn bộ phần trong tuyến tiền liệt ra khỏi lớp vỏ ngoài.

Laser Holmium

Laser dùng để tách và cầm máu mô với ít chảy máu.

Morcellation

Nghiền nhỏ mô đã bóc tách để lấy ra ngoài.

Xuất tinh ngược dòng

Cực khoái không có tinh dịch — tác dụng phụ thường gặp, không gây hại.

SAU PHẪU THUẬT CÓ GÌ THAY ĐỔI? Hầu hết nam giới có dòng nước tiểu mạnh và bền vững. Như các phẫu thuật tuyến tiền liệt khác, **xuất tinh ngược dòng** (cực khoái không có tinh dịch) là phổ biến. Một số người bị tiểu gấp tạm thời hoặc rò rỉ nhỏ trong vài tuần đầu, thường tự hồi phục; ảnh hưởng nghiêm trọng đến cương dương hoặc tiểu không kiểm soát kéo dài là hiếm gặp.

Cách chuẩn bị

- Thực hiện dưới **gây mê toàn thân hoặc gây tê tủy sống** — tuân thủ hướng dẫn nhịn ăn và dùng thuốc.
- Xét nghiệm nước tiểu** để loại trừ nhiễm trùng trước phẫu thuật.
- Nhờ người đưa đón; chuẩn bị cho thời gian đặt ống thông ngắn.

Quá trình & Sau khi phẫu thuật

- Bạn được gây mê hoặc gây tê; kháng sinh được dùng trước.
- Laser bóc tách phần trong tuyến tiền liệt, sau đó được nghiền nhỏ và lấy ra ngoài.
- Đặt ống thông, thường rút sau khoảng **một ngày**; nhiều bệnh nhân ra về trong ngày hoặc sau một đêm.

Nước tiểu có thể **lẫn máu nhạt** và có cảm giác nóng rát/tiểu gấp trong vài tuần; tập bài tập cơ sàn chậu nếu được hướng dẫn, tránh rặn và nâng vật nặng.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Không thể đi tiểu** sau khi rút ống thông
- Chảy máu nhiều hoặc cục máu đông** cản trở dòng chảy
- Sốt hoặc ớn lạnh
- Rò rỉ không cải thiện trong những tuần đầu

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- HoLEP dùng laser bóc tách toàn bộ phần trong tuyến tiền liệt qua ống nội soi — phù hợp với **mọi kích thước**, ít chảy máu và kết quả bền vững.
- Dòng nước tiểu sẽ mạnh hơn; xuất tinh ngược dòng là phổ biến, tiểu gấp/rò rỉ sớm thường tự hồi phục.
- Thời gian đặt ống thông ngắn. Gọi ngay nếu không thể đi tiểu, chảy máu nhiều, hoặc sốt.